

考前題庫出題格式說明

※請依照下列步驟將考題繕打於下一頁：

1. 請依下一頁**標準範例格式**繕打考題(**請依規定出題數**)，並請委員出完題數後**檔案另存新檔時，請於檔名註明委員姓名及題數**，並請 mail 至學會信箱 tastro@tastro.org.tw，以利考題統整及事後查核，謝謝！

註：**符合出題格式之委員**，將由學會於會後給付出題酬勞費予出題委員(100元/題)，故請於出題後檔案務必註明出題者及題數，謝謝！

※ 題目請以**中文出題(限定)**，但專有名詞應用英文(免加註中文)。

※ 題目類型為**四選一**，禁出『**以上皆非或是以上皆是**』之選項。

※ 參考文獻為教科書，排除期刊，考 trial 需是教科書中有寫的

※ AJCC 第八版

※ 題目及選項文字切勿太過冗長。

※ 出題時務必註明該題的「**出處**」。

2. 本格式已設定好樣式，故請依下一頁範例格式繕打，切勿更改其樣式。
3. 開始撰打考題→先於工作列上點選**“格式”**，下拉式選單中點選**“樣式與格式”**，該樣式的格式設定將會出現在螢幕的右方，請使用該格式來控制考題的格式。
 - a. 點選 Question: 可用來控制**題號(題目)**
 - b. 點選 Choice: 可用來控制**答案選項**，自動產生 A) B) C) D)，若續按 Enter 會繼續產生 E) F)...選項，需到樣式選項點選 Answer
 - c. 點選 Answer: 可用來控制**答案格式(本項請再文字註明，出題的小組科別細項)**
 - d. 點選 QuizLevel: **難易度**
 - e. Ref: **參考文獻**
 - f. Comment: **註解(文字請限於 4 行內)**

6. 以上步驟若無法執行，請您用**複製的方式**，將下頁的範例題目複製後，貼上出題次數，然後將原內容文字刪除，保留格式，再將新的考題內容文字加入。

貼心提醒：

1. 請各委員於 **107.06.29(星期五)前**將出題檔 **MAIL 至本會專屬信箱** tastro@tastro.org.tw，信件主旨請註明：**107 年甄審考前出題 xxx 委員 xx 科目**
2. **附檔-保密協議書填寫完後亦請於 107.06.29 日前一併與考題 mail 回傳本會信箱，謝謝！**

「請各出題委員繕打考題時，一定要使用此格式，請勿自行變更該格式」謝謝！

「以下為範例出題格式，請各委員出題時，請以下列格式繕打，切勿變更其格式，謝謝！」

1. () 有關 AJCC 8th 的 Mesothelioma 之描述，下列何者為誤？

- A) T3 為 potentially resectable, T4 為 technically unresectable 的 disease
- B) 已將 AJCC 7th 的 T1a 及 T1b 合併成 T1 disease
- C) 已將 AJCC 7th 的 N1 及 N2 合併成 N1 disease
- D) 遠端轉移分為 M1a 及 M1b

(1 答案): **D (肺及肺中膈)**

(1 難易度): 簡易

(1 參考文獻): American Joint Committee on Cancer 8th (2017); Staging of Malignant Pleural Mesothelioma.

(1 註解): P457, T1a was consolidated with T1b into T1; N1 was consolidated with N2 into N1.

2. () 有關 AJCC 8th 的 Lung cancer 之描述，下列何者為誤？

- A) Tumor 大於 7 cm，由 AJCC 7th 的 T4 變成 AJCC 8th 的 T3 disease
- B) Tumor 吃到 diaphragm 由 AJCC 7th 的 T3 變成 AJCC 8th 的 T4 disease
- C) 歸類出新的 M1c disease
- D) 淋巴結的分期(N)，沒有變化

(2 答案): **A (肺及肺中膈)**

(2 難易度): 簡易

(2 參考文獻): American Joint Committee on Cancer 8th (2017); Staging of Lung cancer.

(2 註解): P431, Tumor >7 cm are now included in T4.

3. () 有關非小細胞癌(Non-small cell lung cancer)之描述，下列何者為誤？

- A) 目前沒有證據支持在未診斷肺癌的一般人身上進行篩檢，可以降低死亡率
- B) 治療前應有病理切片，若切片結果未顯示惡性，應再次進行切片
- C) 最常發生的 EGFR 突變為 exon 19 deletion 或 exon 21 L858R 的點突變
- D) 如果檢測出 EGFR 有 T790M 的突變，通常被認為對於 TKI (tyrosine-kinase inhibitor) 的治療效果較差

(3 答案): **A (肺及肺中膈)**

(3 難易度): 中等

(3 參考文獻): Principle and Practice of Radiation Oncology, 6th ed, 2013; Chapter 51, p938-942.

(3 註解): P942, NLST: all-cause mortality was reduced in the CT screening group by 6.7% when compared with the control group (p=.02).

4. () 有關肺癌的放射治療設計，下列何者不是 QUANTEC 中建議的劑量限制？

- A) Lung V₅ < 60%

- B) Lung $V_{20} < 30\%$
- C) Mean pericardial dose < 26 Gy
- D) Mean lung dose (MLD) < 40 Gy

(4 答案): **D (肺及肺中膈)**

(4 難易度): 簡易

(4 參考文獻): Perez and Brady's principles and practice of radiation oncology, 6th edition, E Halperin, C Perez, L Brady; Chapter 51, p960.

(4 註解): P960, Risk of radiation pneumonitis is $< 20\%$ when mean lung dose (MLD) is less than approximately 20 Gy.

5. () 針對 Small cell lung cancer 的 prophylactic cranial irradiation (PCI) 之描述，下列何者為誤？

- A) 根據 EORTC 08993-22993，PCI 能夠顯著降低 extensive stage disease 的 brain metastases rate，以及增加 OS
- B) 根據 Auperin 的 meta-analysis，PCI 雖然能夠顯著降低 brain metastases rate 以及增加 OS，但是其評估 C/T response 大部分是利用 CXR 而不是 chest CT image
- C) 一篇 intergroup trial 針對 limited-stage disease 比較 PCI dose: 25 Gy/10 fx 以及 36 Gy/18 fx。其結果兩者的 2-year brain metastases 以及 OS 沒有顯著差別
- D) 最近 2017 年日本的 RCT 研究顯示，PCI 可能甚至會降低病人的 OS

(5 答案): **C (肺及肺中膈)**

(5 難易度): 困難

(5 參考文獻): Principle and Practice of Radiation Oncology, 6th ed, 2013; Chapter 51, p968.

(5 註解): P968, Patients with limited-stage SCLC who had achieved a complete response to chemoradiotherapy were randomized to receive PCI in standard dose, 25 Gy in 10 daily fractions, or high-dose, 36 Gy in either 18 daily fractions or 24 twice-daily fractions. In this study, 720 patients were randomized; at 2 years, the cumulative incidence of brain metastases was not significantly different between the two arms: 29% in the standard dose arm versus 23% for high dose. Surprisingly, there was poorer OS in the high-dose arm: 2-year survival was 42% in the standard dose arm versus 36% for high dose. This was attributed to a higher cancer-related mortality in the high-dose arm.

6. () 下列何者不是 Small cell lung cancer (SCLC) 的不良預後因子？

- A) Female gender
- B) Poor performance status
- C) Extensive staging
- D) Abnormal lactate dehydrogenase levels at baseline

(6 答案): **A (肺及肺中膈)**

(6 難易度): 中等

(6 參考文獻): Perez and Brady's principles and practice of radiation oncology, 6th edition, E Halperin, C Perez, L Brady; Chapter 51, p966.

(6 註解): P966, Other clinical factors consistently reported to correlate with improved survival include good performance status, female gender, and normal lactate dehydrogenase levels at baseline.

7. () 一個年輕的小伙子帶著一份病理報告來到您的門診，病理報告顯示 Mediastinal tumor, tumor resection: Invasive thymoma, WHO type B2. Tumor size = 7.4 cm. Transcapsular invasion (+). Surgical margin: Free。請您幫他打出 Masaoka stage，並且給他什麼建議最合適？
- A) Stage IIA，建議 post-operative R/T
 - B) Stage IIB，建議 post-operative R/T
 - C) Stage IIA，建議 post-operative CCRT
 - D) Stage IIB，建議 post-operative CCRT

(7 答案): **B (肺及肺中膈)**

(7 難易度): 簡易

(7 參考文獻): NCCN Guidelines Version 2018. Thymomas and Thymic Carcinomas

(7 註解): ST-1; THYM-3, Microscopic transcapsular invasion: stage IIA; Thymoma stage II→Consider postoperative RT.

8. () 有關 Thymoma 治療之描述，下列何者為誤？
- A) 對於 stage II, III 的 thymoma，R0 resection 過後，可以考慮輔助性化療以及電療
 - B) 利用質子(proton therapy)治療，能夠降低對心臟以及食道的副作用
 - C) 目前有證據顯示 neoadjuvant chemotherapy 後合併手術的 response rate 很不錯
 - D) 目前有證據顯示 neoadjuvant radiotherapy 後合併手術的 response rate 很不錯

(8 答案): **A (肺及肺中膈)**

(8 難易度): 中等

(8 參考文獻): Perez and Brady's principles and practice of radiation oncology, 6th edition, E Halperin, C Perez, L Brady; Chapter 52, p980.

(8 註解): P980, The most promising use of chemotherapy is in the neoadjuvant setting.

9. () 有關 Germ cell tumor 之描述，下列何者為誤？
- A) Primary mediastinal germ cell tumor 的組織型態與 Testicular germ cell tumor 相同
 - B) Primary mediastinal germ cell tumor 的預後比 Testicular germ cell tumor 差
 - C) Seminoma 對化學治療及放射治療反應不佳，需要手術切除
 - D) Nonseminomatous germ cell tumor 接受化學治療後若有殘存腫瘤，需要手術切除

(9 答案): **C (肺及肺中膈)**

(9 難易度): 中等

(9 參考文獻): Perez and Brady's principles and practice of radiation oncology, 6th edition, E Halperin, C Perez, L Brady; Chapter 52, p985.

(9 註解): P985, Seminomas are quite sensitive to both radiation therapy and chemotherapy.

10. () 有關 mediastinal germ cell tumors 之描述，下列何者為誤？

- A) 診斷 mediastinal germ cell tumors 的病人，約有 20%與 Turner syndrome (45,X)有關
- B) 與 gonadal germ cell tumor 比較，mediastinal germ cell tumors 更加 aggressive 且預後較差
- C) 約有 70-80%的病人 serum α -fetoprotein levels (AFP)會升高，而約有 30-50%左右的病人其 β -HCG 及 LDH 會升高
- D) Histologic type 同樣可分為 seminomas 以及 nonseminomatous type，其中 nonseminomatous type 較容易遠端轉移

(10 答案): A (肺及肺中膈)

(10 難易度): 中等

(10 參考文獻): Principle and Practice of Radiation Oncology, 6th ed, 2013; Chapter 52, p984.

(10 註解): P984, Klinefelter syndrome has been documented in patients with mediastinal germ cell tumors but not in patients with testicular germ cell tumors. In one study, up to 20% of patients with mediastinal germ cell tumors were found to have the Klinefelter karyotype (47,XXY)..

11. () 有關 Tracheal cancer 之描述，下列何者為誤？

- A) 最常使用的治療方法為手術切除合併術後的放射治療。目前化療的角色還尚未有定論
- B) 目前已有大型的 clinical trial 證實 CCRT 的治療方式較開刀來得更合適
- C) 過去曾有文獻報告利用 palliative intraluminal brachytherapy 治療，可增加病人的存活率以及生活品質
- D) R/T 的副作用可能有 tracheoesophageal fistula、esophageal stricture, and severe tracheal crusting

(11 答案): B (肺及肺中膈)

(11 難易度): 簡易

(11 參考文獻): Principle and Practice of Radiation Oncology, 6th ed, 2013; Chapter 52, p991-994.

(11 註解): P992, Resectability is universally associated with lower mortality in reported series and as such is the initial strategy for most tracheal primaries.